



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
PENGELOLAAN PENGADUAN
PASIEN DAN KELUARGA
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 999.3/I-PND/DIR/XI/2025

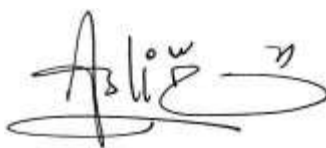
Tentang
Panduan Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB HPK



Fadhila Ayu Setyani, S. Kep. Ners

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi hak-hak pasien dan kewajiban pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang dan pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini, pelayanan rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 01 November 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes



TIM PENYUSUN

Pengarah dan Editor:

Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP

Penyusun:

1. Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb.,SE
2. Daning Pravitia YSM, STr.Keb
3. Novita Pratama, Amd.Keb
4. Putri Indah Purnamasari, Amd.Keb
5. Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.,Ns
6. Amilatul Kholifah, Amd.Kep
7. Ns. Nazhilatul Rizkia, S. Tr. Kep



DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	ii
Tim Penyusun.....	ii
Daftar Isi.....	ii
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Pengertian.....	2
Bab II Ruang Lingkup.....	2
2.1 Pengorganisasian.....	2
2.2 Wewenang Dan Tanggung Jawab.....	2
Bab III Tata Laksana.....	2
3.1 Penanganan Pengaduan Pelayanan Pada Jam Kerja.....	2
3.2 Penanganan Pengaduan Pelayanan Diluar Jam Kerja.....	2
Bab IV Penutup.....	2



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 999.3/I-PND/DIR/XI/2025

TENTANG

PANDUAN PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN KELUARGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa pengaduan pasien dan keluarga merupakan salah satu bentuk peran serta pasien dan keluarga dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit;
- Mengingat : (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- (5) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- (6) Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN PENGADUAN PASIEN DAN KELUARGA

Pasal 1

- (1) Sistem pengaduan pelayanan di unit pelayanan dilaksanakan secara konsisten dalam menghadapi keluhan, konflik, atau beda pendapat.
- (2) Pasien diberitahu tentang proses menyampaikan keluhan, konflik, atau perbedaan pendapat.
- (3) Keluhan, konflik, dan perbedaan pendapat ditelaah serta ditindaklanjuti oleh rumah sakit serta didokumentasikan.
- (4) Pasien dan atau keluarga pasien ikut serta dalam proses penyelesaian.

Pasal 2

Pelayanan Pengaduan

- (1) Pengelolaan pengaduan pasien dan keluarga ditanggapi sesegera mungkin sejak pengaduan diterima, maksimal 1x24 jam.
- (2) Pengelolaan pengaduan meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan lebih lanjut, pelaporan, dan pengarsipan.
- (3) Pengelolaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban, dan penyaluran / penerusan kepada unit terkait yang berwenang menangani.
- (4) Pengaduan pelayanan di unit pelayanan telah sesuai dengan regulasi



Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 999.3/I-PND/DIR/XI/2025
TENTANG
PANDUAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PASIEAN DAN KELUARGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat sekarang ini pasien dan keluarga sudah semakin cermat dan kritis terhadap produk jasa yang diperolehnya termasuk pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan. Hal ini tentunya memacu instansi rumah sakit khususnya rumah sakit swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari pra sampai pasca pelayanan. Pelayanan yang prima akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit tersebut.

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien. Melalui mottonya, Sahabat Setia Menuju Sehat, RS Prima Husada berkomitmen untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik kepada pasien dan keluarga, memberikan penjelasan medis yang komprehensif kepada seluruh pasien dan menjunjung tinggi keselamatan pasien serta hak dan kewajiban pasien.

Rumah Sakit mengidentifikasi kebijakan dan Prosedur bagi mereka yang perlu dilibatkan dalam menyelesaikan keluhan dan bagaimana pasien dan keluarganya dapat ikut berperan serta antara lain :

- a. Pasien diberikan informasi mengenai proses untuk menyampaikan keluhan dalam proses yang harus dilakukan pada saat terjadi Konflik/Perbedaan pendapat pada proses perawatan.
- b. Keluhan, konflik dan perbedaan pendapat tersebut di kaji dan di selesaikan oleh unit/petugas yang bertanggung jawab melalui sebuah alur/Proses spesifik.
- c. Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses penyelesaian keluhan, konflik dan perbedaan pendapat.

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan pasien dan keluarga akan pelayanan yang lebih baik, pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan terbaik sehingga pasien merasa aman dan nyaman selama menjalankan proses perawatan kesehatan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit, tentunya tidak bisa terlepas dari adanya pengaduan yang terjadi antara pasien dan rumah sakit. Pengaduan merupakan



pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap orang atau unit atau organisasi yang menghasilkan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Meningkatnya kesadaran hukum pasien dan keluarga secara langsung mendorong pasien dan keluarga untuk menuntut haknya sebagai pasien dalam menerima pelayanan kesehatan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan telah diatur tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang diharapkan dalam penerapannya dilaksanakan secara berimbang. Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, kemungkinan muncul atau timbulnya tuntutan hukum baik tuntutan pidana, gugatan perdata maupun administrasi terhadap petugas atau pelaksana profesional dan manajemen sangat besar. Oleh karena itu pengaduan harus diselesaikan secepat mungkin sehingga hubungan antara pasien dengan rumah sakit dapat terjalin dengan baik dan tidak terjadi konflik yang serius sehingga kepuasan pasien dapat tercapai.

Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima. Keluhan tersebut dicatat, ditelaah, di tindaklanjuti, dan dicari penyelesaiannya bila memungkinkan. Demikian pula, bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan, konflik, atau dilema lain bagi rumah sakit dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan, dan lainnya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, etis, pengobatan atau pemulangan pasien, dsb.

Rumah sakit menetapkan cara-cara dalam mencari solusi terhadap dilema dan keluhan tersebut. Rumah sakit mengidentifikasi dalam regulasi, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses, serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Setelah membaca pedoman ini, diharapkan mampu memahami bagaimana cara penanganan pengaduan sehingga semua pengaduan dari pasien bisa diselesaikan secara profesional dan kekeluargaan serta tercapainya kepuasan pasien.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pengaduan pelayanan pasien dan keluarga meliputi:

- a. Pengaduan pasien dan keluarga,
- b. Penanganan pengaduan pasien dan keluarga,
- c. Pelaporan dan pemantauan

1.4 Pengertian

1. Pengaduan pasien dan keluarga adalah bentuk pengawasan pasien dan keluarga yang disampaikan oleh pasien dan keluarga kepada rumah sakit, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
2. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga yang adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
3. Pelapor adalah individu atau kelompok pasien dan keluarga yang menyampaikan pengaduan kepada rumah sakit.
4. Terlapor adalah staf atau kelompok pasien dan keluarga yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
5. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan/diadukan;



6. Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang memberikan penjelasan/data/dokumen/bukti-bukti mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait;
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pengaduan pasien dan keluarga.



BAB II RUANG LINGKUP

1.1 PENGORGANISASIAN

Penyelesaian penanganan pengaduan di rumah sakit merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit.

Penanganan pengaduan pelayanan non medis di rumah sakit melibatkan unit-unit kerja atau pihak-pihak terkait yang meliputi:

- 2.1.1 Penanganan pengaduan pelayanan non medis di rumah sakit dilakukan oleh:
 - a. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)
 - b. Unit/Instalasi terkait
Manajemen (Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Manajer On Duty Rawat Jalan dan Rawat Inap)
- 2.1.2 Penanganan pengaduan pelayanan medis di rumah sakit dilakukan oleh :
 - a. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)
 - b. Komite Medik didampingi manajemen (Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Manajer On Duty Rawat Jalan dan Rawat Inap)
 - c. Unit/Instalasi terkait

1.2 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

2.2.1 Manajemen Rumah Sakit

- a. Wewenang
 - 1) Bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.
 - 2) Mengarahkan / menginstruksikan satuan kerja terkait dalam penyelesaian pengaduan.
 - 3) Memberdayakan potensi dalam upaya penyelesaian penanganan pengaduan.
- b. Tanggung Jawab
 - 1) Menyelesaikan penanganan pengaduan di rumah sakit.
 - 2) Mengambil langkah strategis baik eksternal maupun internal dalam pengaduan pelayanan medis dan non medis.
 - 3) Mengamankan dokumen dan informasi penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 4) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan clinical governance.
 - 6) Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelesaian penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.
 - 7) Melakukan pembinaan terhadap tenaga medis dan non medis.
 - 8) Melakukan advokasi kepada tenaga kesehatan yang diduga terkait penanganan kasus hukum pelayanan medis.

2.2.2 Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP)

- a. Wewenang



- 1) Bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyelesaian pengaduan.

b. Tanggung Jawab

- 1) Menyelesaikan penanganan pengaduan di rumah sakit.
- 2) Mengambil langkah strategis secara internal dalam penanganan pengaduan pelayanan non medis.
- 3) Mengamankan dokumen dan informasi penanganan pengaduan pelayanan non medis.
- 4) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis dan non medis.

2.2.3 Komite Medik

a. Wewenang

- 1) Membuat kebijakan yang tertuang di dalam medical staf by laws.
- 2) Melakukan kredensial terhadap tenaga medis.
- 3) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan tugas tenaga medis.
- 4) Melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga medis.
- 5) Melakukan audit medik.
- 6) Melakukan pembinaan terhadap tenaga medic yang melakukan pelanggaran disiplin profesi.
- 7) Melakukan advokasi kepada tenaga medis yang diduga terkait penanganan kasus hukum pelayanan medis.

b. Tanggung Jawab

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bidang Hukum Rekam Medis, Bidang Keperawatan dan unit kerja yang terkait.
- 2) Melakukan pengumpulan data/informasi baik dari informasi langsung maupun melalui dokumen.
- 3) Memfasilitasi pertemuan multi disiplin untuk peninjauan kasus dengan melibatkan organisasi profesi dan bagian/bidang hukum.
- 4) Melakukan analisis terhadap sengketa medis yang terjadi.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam penyelesaian kasus dan upaya-upaya pencegahan kasus serupa dikemudian hari.



BAB III TATA LAKSANA

2.1 Penanganan Pengaduan Pelayanan Pada Jam Kerja

3.1.1 Menerima pengaduan

Unit kerja terkait menerima pengaduan dari pasien.

3.1.2 Mengelola pengaduan

Unit kerja dan PIPP yang menerima pengaduan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat dan mengkaji informasi
 - a. Identitas dan kondisi pasien
 - b. Peristiwa
 - c. Tuntutan pasien
2. Menanggapi pengaduan
 - a. Mengucapkan terimakasih atas laporan
 - b. Menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan
 - c. Memberikan penjelasan sementara sesuai kewenangan dan berusaha untuk menenangkan pasien/keluarga pasien
 - d. Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti.
 - e. Seluruh pengaduan dicatat dalam formulir pengaduan.
 - f. Laporkan pengaduan kepada atasan/karu apabila pasien/keluarga tidak puas dengan jawaban petugas pada hari itu
 - g. Kepala ruangan melakukan klarifikasi ulang, memberikan penjelasan dan mengupayakan penyelesaian ditingkat unit.
 - h. Kepala ruangan melaporkan kepada Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) atau Manajemen pada hari yang sama jika pasien/keluarga pasien masih belum puas.
 - i. Manajemen menerima laporan pengaduan dan melakukan telaah bersama unit terkait.
 - j. Jika jawaban sudah diterima Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) dan Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) akan menyampaikan jawabannya kepada pasien/keluarga pasien.
 - k. Bila pasien/keluarga pasien tidak puas dengan jawaban Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) akan akan melaporkan kepada pihak Manajemen untuk mengatasi permasalahannya
3. Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) melaporkan pengaduan ke Direktur RS
 - a. Memberi pertimbangan
 - b. Meminta pengarahan tindak lanjut
4. Menindaklanjuti instruksi Direktur



3.1.3 Investigasi Kasus

1. Membahas kebenaran informasi tentang:
 - a. Identitas pasien
 - b. Peristiwa
 - c. Rekam medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
2. Penataan dokumen (khusus pengaduan pelayanan medis) yang meliputi:
 - a. Dokumentasi informasi
 - b. Berkas rekam medis (medical record)
 - c. Dokumen persetujuan tindakan medis
 - d. Dokumen persetujuan tindakan medis tertentu (operasi)
 - e. Second opinion
 - f. Resume medis
 - g. Pendapat organisasi profesi
 - h. Juklak, Juknis dan SPO Pelayanan
3. Mengadakan rapat dengan bagian terkait
4. Rapat dengan Komite Medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - a. Pertimbangan aspek medis
 - b. Pertimbangan aspek manajemen
 - c. Pertimbangan aspek medicolegal
5. Pendapat Komite Etik Rumah Sakit

3.1.4 Analisa Kasus

1. Hasil rapat koordinasi menentukan atau memilah kategori kasus dan selanjutnya menugaskan unit terkait untuk menindaklanjuti:
 - a. Kasus Etik ditangani oleh MKEK/MDTK/MKDK/KERS
 - b. Kasus Administrasi ditangani oleh Customer Service
 - c. Kasus Hukum ditangani oleh Bagian/Bidang Hukum
 - d. Kasus Gabungan ditangani oleh Bagian/Bidang Hukum
2. Telaahan Kasus
Masing-masing unit diatas menyusun telaahan kasus. Didalam menelaah kasus, hal-hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Kebenaran identitas pasien
 - b. Kebenaran peristiwa
 - c. Pertimbangan prosedur tindak lanjut
3. Masing-masing unit dimaksud melaporkan hasil telaahan disertai rekomendasi kepada manajemen.

3.1.5 Tindak lanjut penanganan kasus

1. Pendalaman kasus:
 - a. Pendapat manajemen rumah sakit
 - b. Pendapat Komite Medis (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - c. Pendapat konsultan hukum (apabila diperlukan)
2. Penyimpulan posisi kasus ditinjau dari:



- a. Kewenangan dan kompetensi
 - b. Indikasi dan kontra indikasi (khusus pengaduan pelayanan medis)
 - c. Persetujuan tindakan medic / informed consent
 - d. Kesesuaian tindakan dengan SPO
 - e. Hukum dan Perundang-undangan
3. Putusan manajemen tentang pilihan penyelesaian kasus
- a. Apabila dari hasil pendalaman disimpulkan bahwa secara hukum posisi rumah sakit/staf cukup kuat maka penyelesaian yang dipilih adalah litigasi. Terhadao tuntutan ganti rugi yang lebih kecil dari pada prediksi biaya penyelesaian dapat dipertimbangkan penyelesaian non litigasi (ADR)
 - b. Apabila hasil pendalaman disimpulkan bahwa secara hukum, posisi rumah sakit
 - c. / staf tidak cukup kuat maka penyelesaian yang dipilih adalah non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi).

3.1.6 Penyelesaian kasus

Dalam hal penyelesaian kasus melalui litigasi maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Menunjuk Kuasa Hukum/Penasehat Hukum
2. Menunjuk Staf Bidang / Bagian Hukum sebagai mitra kerja

Dalam hal penyelesaian kasus non litigasi ditempuh:

1. Pihak rumah sakit (manajemen) mengundang pihak pengadu untuk membicarakan penyelesaian kasus secara damai (negosiasi). Dipertemukannya pihak pengadu dengan pertimbangan secara matang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bila upaya negosiasi tidak berhasil maka ditunjuk salah satu orang/badan yang disepakati bersama dan mampu untuk bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus.
3. Hasil perdamaian melalui negosiasi dan mediasi dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum, bila perlu dikuatkan oleh Notaris atau didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

3.1.7 Dokumentasi Kasus

1. Seluruh dokumen yang terkait dengan kasus ditata dan diklarifikasi dengan pengkodean khusus.
2. Dokumen disimpan di Direksi/Wakil Direksi Pelayanan Medik sampai kasus dianggap selesai.
3. Bila kasus telah selesai dokumen dapat dikembalikan ke bagian yang menangani dokumen

3.1.8 Penyelesaian Tuntutan Hukum (tergantung kasus)

1. Diselesaikan dengan proses Perdata, Pidana atau Tata Usaha Negara.
2. Tuntutan harus dianalisa terlebih dahulu

Mekanisme pelaksanaan penanganan kasus hukum pelayanan medis perlu dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:

1. Pengumpulan Informasi dan Bukti
Informasi tentang adanya dugaan terjadi kasus hukum pelayanan medis di rumah sakit, biasanya bersumber dari media massa baik cetak maupun



elektronik atau dari keluhan pasien (keluarga) baik langsung maupun yang disampaikan melalui kotak saran yang disediakan oleh rumah sakit. Selain itu pengaduan lembaga swadaya pasien dan keluarga atau kuasa hukum pasien dapat pula menjadi sumber informasi adanya dugaan kasus hukum pelayanan medis. Atas dasar hal itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Informasi awal dihimpun oleh Unit PIPP
- b. Laporan ke Direksi oleh PIPP
- c. Instruksi/Disposisi dari Direksi kepada Komite Medik dan Bag. Hukum
- d. Komite Medik dan Bagian Hukum melaksanakan Instruksi / Disposisi Direksi.
- e. Komite Medik bersama Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan unit terkait di Rumah Sakit (melengkapi data / dokumen)
- f. Menentukan strategi penanganan kasus:
 - 1) Memilah kasus:
 - 3) Kasus etik,
 - 4) Kasus hukum (pidana, perdata, administrasi/disiplin)
 - 5) Kasus gabungan etik dan hukum
 - 2) Melakukan analisa kasus
 - 3) Menetapkan langkah penanganan
- g. Meminimalisasi dampak negatif dari pemberitaan (pelaksananya adalah PIPP) sesuai dengan SPO.
- h. Melakukan upaya pendekatan kepada keluarga untuk menjelaskan posisi kasus (pelaksananya adalah dokter ruangan didampingi oleh PIPP)
- i. Apabila penjelasan tidak dapat diterima oleh keluarga pasien, maka langkah selanjutnya:
 - 1) Merespon langkah yang dilakukan oleh keluarga pasien/kuasa hukum sesuai dengan tuntutan yang akan dilakukan.
 - 2) Bila tuntutan dilakukan melalui litigasi maka dilakukan langkah persiapan litigasi sesuai dengan SPO.
- j. Bila ada kesepakatan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, maka kasus diselesaikan secara damai.
- k. Setelah ada kesepakatan perdamaian, segera membuat Akta Perdamaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Alat Bukti Kasus Hukum Pelayanan Medis

Dalam kasus hukum pelayanan medis diperlukan bukti, yaitu:

- a. Dokumen informasi kasus medis dari media massa, kotak saran, dll.
- b. Berkas rekam medis:
 - 1) Catatan medis pasien
 - 2) Catatan keperawatan pasien
 - 3) Dokumen persetujuan tindakan medis
 - 4) Dokumen persetujuan tindakan medis tertentu (operasi)
 - 5) Second opinion
 - 6) Resume medis
 - 7) Pendapat organisasi profesi
 - 8) Juklak, juknis dan SPO Pelayanan

2. Mekanisme Penanganan di Rumah Sakit

Apabila telah terjadi penanganan kasus hukum pelayanan medis, maka yang diberi tugas dan wewenang untuk menangani penanganan kasus hukum pelayanan medis adalah Komite Medik dan Bagian Hukum.

Komite Medik dan Bagian Hukum selanjutnya segera mengambil langkah-langkah dengan mengumpulkan dan mempelajari secara seksama informasi yang berkaitan



dengan dugaan adanya penanganan kasus hukum pelayanan medis.

Komite Medis dan Bagian Hukum mempelajari dan menelaah informasi kasus hukum pelayanan medis yang disampaikan oleh pasien, keluarga, LSM ataupun kuasa hukum baik lisan maupun tertulis.

Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilakukan pencatatan meliputi:

a. Identitas pasien

- 1) Nama Pasien
- 2) Nama orang tua pasien
- 3) Umur pasien
- 4) Jenis kelamin pasien
- 5) Alamat Pasien

b. Ringkasan kejadian kasus

- 1) Kronologi kasus
- 2) Petugas yang terkait
- 3) Waktu terjadinya
- 4) Tindakan yang dilakukan
- 5) Rencana/penanganan selanjutnya

c. Kondisi fisik pasien

- 1) Meninggal dunia
- 2) Cacat berat atau ringan
- 3) Luka berat atau ringan
- 4) Keracunan obat atau makanan
- 5) Patah tulang
- 6) Perbuatan tidak menyenangkan
- 7) Lain-lain

d. Pengaduan/Tuntutan Pasien/Keluarga

- a. Laporan
- b. Somasi
- c. Tuntutan: Perdata, Pidana dan Administrasi
- d. Lain-lain

Selanjutnya Bagian Hukum melapor kepada Direksi Rumah Sakit perihal adanya tuntutan pasien dan atas arahan Direksi, Bagian Hukum mengundang rapat koordinasi satuan kerja terkait yaitu Komite Medik, Komite Keperawatan, Bagian Rekam Medik dan unit kerja lain untuk ikut membahas penanganan kasus hukum pelayanan medis dari berbagai aspek.

Rapat pembahasan kasus medis bersifat tertutup, terbatas, rahasia dan jadwal rapat pelaksanaan tersebut harus dilaporkan secara tertulis kepada Direksi Rumah Sakit. Saat rapat koordinasi pembahasan penanganan kasus hukum pelayanan medis, masing-masing peserta rapat harus membawa bukti-bukti yang terkait dengan penanganan kasus tersebut.

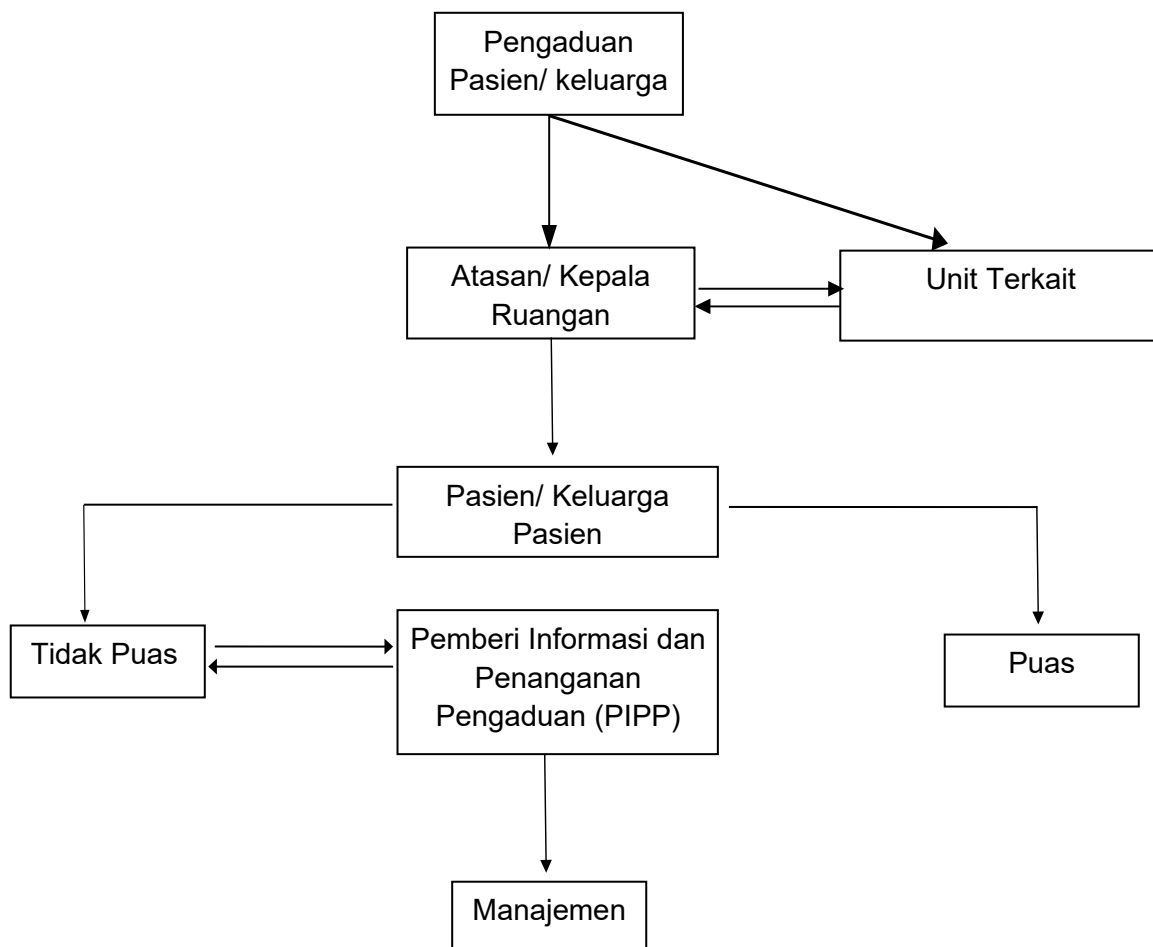
Dalam rapat pembahasan kasus, hal-hal yang harus dibicarakan antara lain:

1. Kebenaran identitas pasien
2. Kebenaran peristiwa yang disampaikan pasien

3. Aspek hukum yang berkaitan dengan doktrin tentang kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
4. Malpraktik medis
5. Etika kedokteran
6. Status kepegawaian, surat izin praktik dan surat pengesahan dari Departemen Kesehatan bagi dokter yang menangani
7. Indikasi medis
8. Persetujuan tindakan medis
9. Catatan medis dan catatan keperawatan apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Kehati-hatian penanganan sesuai SPO.
11. Penerapan juklak dan juknis sarana dan prasarana pelayanan.
12. Tuntutan pasien.

Apabila dalam rapat pertama belum dapat diambil kesimpulan dan langkah- langkah penanganan yang diperlukan, bahkan bila dipandang perlu untuk diadakan pendalaman lebih lanjut, maka pembahasan kasus hukum pelayanan medis dapat dilanjutkan pada waktu lain yang disepakati oleh seluruh peserta rapat.

Setiap kali rapat pembahasan kasus, harus dibuatkan daftar hadir peserta rapat dan risalah rapat dengan klasifikasi rahasia yang disampaikan secara terbatas hanya pada peserta rapat dan Direksi rumah sakit.



Gambar 3. 1 Alur Proses Penanganan Pengaduan Pada Jam Kerja



2.2 Penanganan Pengaduan Pelayanan Diluar Jam Kerja

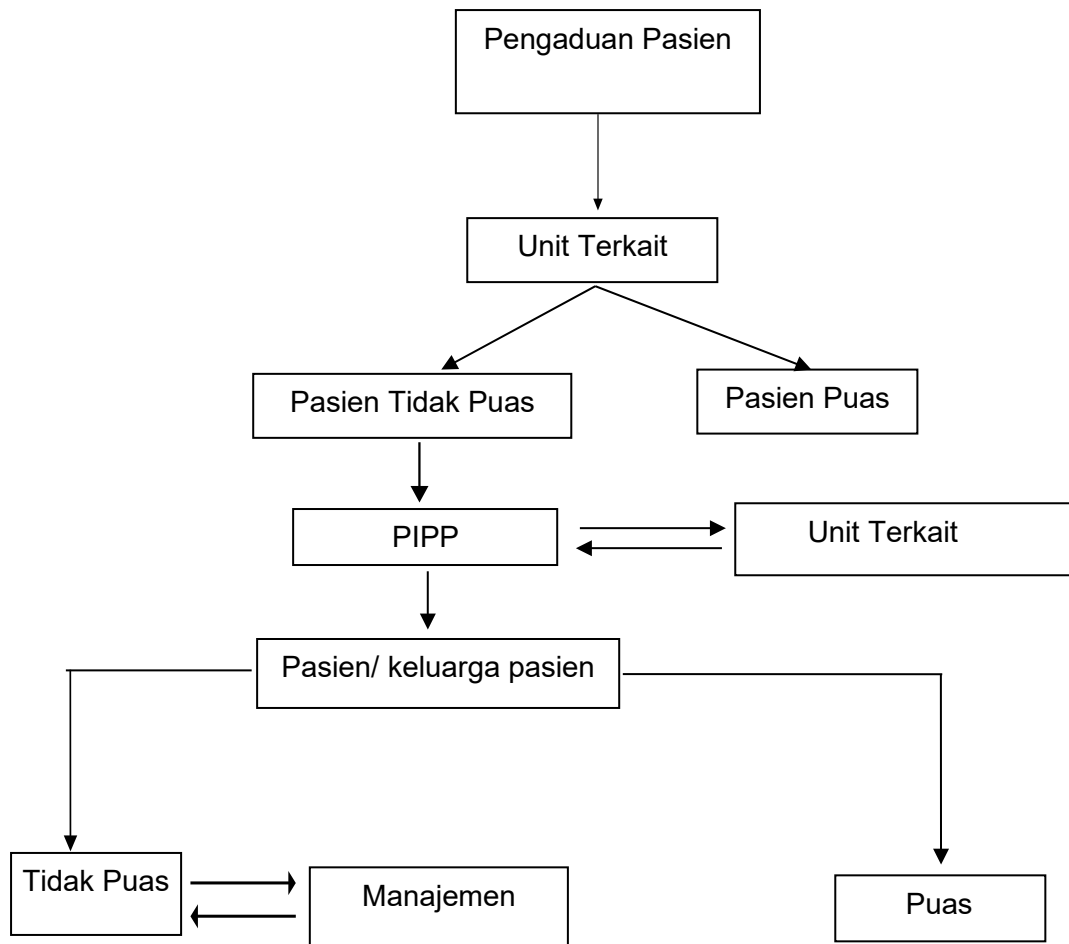
3.2.1 Menerima pengaduan

Unit kerja terkait menerima pengaduan dari pasien.

3.2.2 Mengelola pengaduan

Unit kerja yang menerima pengaduan harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencatat dan mengkaji informasi
 - a. Identitas dan kondisi pasien
 - b. Peristiwa
 - c. Tuntutan pasien
2. Menanggapi pengaduan
 - a. Mengucapkan terima kasih atas laporan.
 - b. Memberikan penjelasan sementara kepada pasien dan berusaha untuk menenangkannya.
 - c. Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti.
 - d. Laporkan pengaduan kepada Penanganan Pengaduan (PIPP) apabila pasien tidak puas dengan jawaban petugas pada hari itu juga.
 - e. Bila pasien tidak puas dengan jawaban Penanganan Pengaduan (PIPP), maka minta pasien untuk mengisi formulir pengaduan untuk disampaikan ke manajemen.
 - f. Penanganan Pengaduan (PIPP) memberikan formulir pengaduan tersebut kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti
 - g. Bila pasien/keluarga pasien tidak puas dengan jawaban Penanganan Pengaduan (PIPP), Penanganan Pengaduan (PIPP) akan melaporkan kepada pihak Manajemen untuk mengatasi permasalahannya.



Gambar 3.2 Alur Proses Penanganan Pengaduan Di Luar Jam Kerja



BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pasien dan Keluarga ini dapat dijadikan acuan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan dalam menangani pengaduan pasien meliputi penelahaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga diharapkan dapat dilakukan penanganan pengaduan pasien dan keluarga secara cepat, cermat dan berkualitas.

Langkah selanjutnya adalah mendorong Pimpinan Instansi/Unit Kerja untuk menindaklanjuti pengaduan pasien dan keluarga guna memperbaiki mutu pelayanan di unit kerjanya.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 01 November 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes